

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (ADAS-COG)

Eje V: Neurocognición y Demencias • Estándar Oro de Eficacia Terapéutica Cognitiva de Mohs y Davis

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Evaluación de la Enfermedad de Alzheimer - Subescala Cognitiva (ADAS-Cog).
Nombre Original	Alzheimer's Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale (Mohs et al., 1983; Rosen et al., 1984).
Autores Originales	Richard C. Mohs, Ph.D., W. G. Rosen, M.D. y Kenneth L. Davis, M.D. (Mount Sinai School of Med.).
Adaptación Hispana	Manubens et al. (1998); Peña-Casanova et al. (1997); Grupo NORMACODEM, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Gravedad del deterioro cognitivo y memoria en demencia.
Tipo de Instrumento	Batería neuropsicológica breve de ejecución heteroaplicada por examinador clínico entrenado.
Composición de Tareas	11 tareas cognitivas estandarizadas (ADAS-Cog-11; versión extendida 13 tareas).
Población y Rango	Adultos mayores (≥ 55 años) con sospecha o diagnóstico de demencia tipo Alzheimer.
Tiempo de Administración	30 a 45 minutos de evaluación interactiva presencial.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para ensayos de investigación académica y práctica asistencial clínica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CRITERIO REGULATORIO INTERNACIONAL (FDA / EMA)

La **ADAS-Cog** fue creada en la Escuela de Medicina de Mount Sinai (Mohs, Rosen & Davis, 1983) con el propósito explícito de medir con máxima precisión y linealidad el cambio cognitivo longitudinal en la enfermedad de Alzheimer:

- Estándar Regulatorio Primario:** Es el instrumento primario de eficacia cognitiva exigido formalmente por la FDA (EE. UU.) y la EMA (Europa) para la autorización y aprobación de fármacos antidemencia (inhibidores de colinesterasa, memantina y anticuerpos monoclonales anti-amiloide).
- Cuantificación de Errores:** A diferencia de los tests de inteligencia tradicionales, la ADAS-Cog puntúa el **número de fallos y errores**; una mayor puntuación refleja una peor ejecución neuropsicológica.
- Sensibilidad en Fases Leves a Moderadas:** Detecta con gran fineza la progresión anual de declive cognitivo típico de la EA (aproximadamente 5 a 8 puntos de deterioro al año sin tratamiento).

3. TAREAS COGNITIVAS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (ADAS-COG-11 / 70 PUNTOS)

Tarea Cognitiva	Rango Errores	Procesos Neuropsicológicos Explorados
1. Evocación de Palabras	0 a 10 errores	Memoria episódica verbal verbal inmediata tras 3 ensayos de lista de 10 palabras.
2. Denominación de Objetos	0 a 5 errores	Acceso léxico y denominación por confrontación visual de 12 objetos y dedos.
3. Órdenes Verbales	0 a 5 errores	Comprensión auditiva verbal compleja con instrucciones multietapa secuenciales.
4. Praxis Constructiva	0 a 5 errores	Copia de figuras geométricas bidimensionales (círculo, polígonos, cubos).
5. Praxis Ideatoria	0 a 5 errores	Ejecución de un plan motor complejo (doblar papel, meter en sobre, sellar).
6. Orientación	0 a 8 errores	Orientación temporal (día, mes, año) y espacial (lugar, ciudad).
7. Reconocimiento de Palabras	0 a 12 errores	Memoria de reconocimiento visual de palabras aprendidas vs. distractoras.
8. Recuerdo de Instrucciones	0 a 5 errores	Memoria de trabajo y monitorización de las reglas de las pruebas.
9. Lenguaje Hablado Global	0 a 5 errores	Claridad de la expresión oral, fluidez y coherencia en la conversación.
10. Dificultad Expresiva	0 a 5 errores	Frecuencia de anomia, circunloquios y perseveraciones en el diálogo.
11. Comprensión del Lenguaje	0 a 5 errores	Capacidad para comprender las explicaciones del evaluador a lo largo de la sesión.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de Manubens et al. (1998) y el Proyecto NORMACODEM (Peña-Casanova et al., 1997; $N = 450$) confirman su idoneidad:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.92	Alta cohesión psicométrica entre tareas en pacientes con demencia.
Concordancia Interevaluador	CCI = 0.92 - 0.97	Excelente reproducibilidad entre examinadores clínicos con entrenamiento estandarizado.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.89 - 0.93	Gran estabilidad temporal en intervalos de 1 mes en ausencia de progresión.
Sensibilidad al Cambio	Efecto d = 0.75 - 1.10	Extraordinaria sensibilidad para capturar desaceleración del declive por fármacos.
Validez Concurrente	$r = -0.82$ (MMSE / MEC)	Fuerte correlación inversa con el Mini-Mental State Examination y la CDR ($r = 0.78$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Basada en Déficits (Errores):** En todas las tareas, cada fallo o conducta alterada suma puntos de disfunción.
- **Cálculo de la Puntuación Total ADAS-Cog-11:** Suma directa de los errores obtenidos en las 11 tareas:

$$\text{Puntuación Total ADAS-Cog} = \sum_{i=1}^{11} \text{Puntuación Tarea}_i \quad (\text{Rango: 0 a 70 puntos de error})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, **mayor gravedad del deterioro neurocognitivo**. Una puntuación de 0 representa un rendimiento perfecto sin ningún error registrable.
- **Tasa Anual de Deterioro Natural:** En la evolución no tratada de la Enfermedad de Alzheimer leve-moderada, la tasa promedio de empeoramiento espontáneo es de **5.5 a 7.0 puntos por año**.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango Errores	Equivalente CDR	Estado Cognitivo y Diagnóstico Clínico
Normal / Preservado	0 a 9 pts	CDR 0	Rendimiento cognitivo normal acorde a edad y escolaridad.
DCL / Incipiente	10 a 17 pts	CDR 0.5	Deterioro Cognitivo Leve; fallos en memoria episódica con autonomía.
Demencia Leve	18 a 30 pts	CDR 1	Alzheimer incipiente; olvidos notables, desorientación temporal y anomia.
Demencia Moderada	31 a 50 pts	CDR 2	Deterioro moderado; fallos en comprensión, praxias e interferencia diaria.
Demencia Severa	51 a 70 pts	CDR 3	Deterioro cognitivo avanzado; colapso afaso-apraxo-agnósico profundo.

CRITERIO DE EFICACIA TERAPÉUTICA SIGNIFICATIVA (CAMBIO ≥ 4 PUNTOS):

En ensayos clínicos de farmacología antidemencia, se define como **respuesta clínicamente relevante** una reducción de al menos **4 puntos** respecto a la línea base a los 6 meses, o una estabilización (cambio < 2 puntos) frente al declive esperado de 3-4 puntos en el grupo placebo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN FARMACOLÓGICA EN DEMENCIA

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CON ADAS-OG EN UNIDADES DE MEMORIA:

- **Paso 1 (Línea Base Previa a Medicación):** Administrar ADAS-Cog antes de iniciar inhibidores de la acetilcolinesterasa (Donepezilo, Rivastigmina, Galantamina) o Memantina.
- **Paso 2 (Evaluación Semestral de Respuesta):**
 - *Descenso o Estabilización (< 2 pts de cambio):* Excelente respuesta terapéutica; mantener pauta farmacológica.
 - *Empeoramiento de 2 a 4 pts:* Respuesta intermedia esperada; mantener pauta y reforzar estimulación cognitiva.
 - *Declive acelerado > 6 pts en 6 meses:* Fracaso terapéutico o evento cerebrovascular intercurrente; evaluar cambio de fármaco o combinación biterápica (Donepezilo + Memantina).
- **Paso 3 (Monitorización de Seguridad):** Evaluar praxis ideatoria para detectar posibles apraxias motoras inducidas por progresión cortical.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ENSAYO DE ESTABILIZACIÓN EN ALZHEIMER PRODRÓMICO

Identificación: Varón de 72 años, profesor universitario jubilado, derivado a la Unidad de Trastornos Cognitivos por quejas de desorientación topográfica reciente, olvidos de citas y dificultad progresiva para hallar palabras técnicas en conversaciones.

Evaluación Inicial ADAS-Cog-11:

- **Puntuación Total de Errores = 22 / 70 puntos (Demencia Leve / Estadio Inicial de Alzheimer, CDR = 1).**
- *Desglose de Tareas:* Evocación de palabras = 7/10 fallos; Reconocimiento de palabras = 5/12; Orientación = 3/8; Denominación = 2/5; Lenguaje espontáneo = 2/5; Praxis = 3/10.

Tratamiento Instaurado: Se inició tratamiento con Donepezilo (titulado a 10 mg/día) asociado a un programa domiciliario de estimulación cognitiva computarizada y ejercicio aeróbico diario.

Reevaluación a los 12 Meses: La puntuación en la ADAS-Cog fue de **20 / 70 puntos** (ganancia neta de 2 puntos frente a un declive proyectado de +6 puntos sin tratamiento). El paciente mantuvo la autonomía para compras y aseo personal y preservó la coherencia narrativa en reuniones sociales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EFEECTO SUELO EN DEMENCIA GRAVE:

En pacientes con MMSE < 10, la ADAS-Cog sufre efecto suelo en memoria verbal; recurrir a escalas de demencia avanzada (SIB de Saxton).

SESGO POR ESCOLARIDAD ALTA:

Profesionales con alta reserva cognitiva pueden compensar las tareas de praxis y orientación; examinar detalladamente la evocación libre retardada.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Mohs, R. C., Rosen, W. G., & Davis, K. L. (1983). The Alzheimer's Disease Assessment Scale: An instrument for evaluating treatment efficacy. *Psychopharmacology Bulletin*, 19(3), 448-450.
2. Rosen, W. G., Mohs, R. C., & Davis, K. L. (1984). A new rating scale for Alzheimer's disease. *American Journal of Psychiatry*, 141(11), 1356-1364.
3. Manubens, J. M., et al. (1998). Versión española de la subescala cognitiva de la Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS-Cog). *Neurología*, 13(5), 224-229.
4. Peña-Casanova, J., et al. (1997). Adaptación y baremación de la ADAS-Cog en España: Grupo NORMACODEM. *Revista de Neurología*, 25(141), 660-666.